

Casos de Estudo - Transtornos Térmicos

Casos de estudo de pacientes com transtornos térmicos. Hipertermia: elevação da temperatura corporal acima de 40°C com falha dos mecanismos de termorregulação. Causas: exposição prolongada ao calor, exercício intenso, desidratação, uso de medicamentos que reduzem a sudorese. Sinais clínicos: pele quente e seca, confusão, convulsões, taquicardia, hipotensão. Tratamento imediato: resfriamento ativo, reposição volêmica, monitorização de temperatura retal e vigilância de rabdomiólise e lesão renal.

Casos de estudo de pacientes com transtornos térmicos (continuação). Hipotermia: temperatura central abaixo de 35°C. Classificação: leve (32-35°C), moderada (28-32°C), grave (abaixo de 28°C). Manifestações: tremor, letargia, bradicardia, arritmias, depressão do nível de consciência. Manejo: reaquecimento passivo na forma leve, reaquecimento ativo externo na moderada, e reaquecimento ativo interno (via aérea aquecida, infusão morna, lavagem corporal) na grave. Evitar manuseio brusco que precipite fibrilação ventricular.

Prevenção de transtornos térmicos em pacientes acamados e idosos. Estratégias: hidratação adequada (30-40 mL/kg/dia), ambientes ventilados, roupas leves, monitorização de exposição ao calor nas ondas de calor. Em ambiente hospitalar: controle de temperatura ambiente, avaliação periódica de sinais vitais e resposta térmica. Considerar risco elevado em uso de diuréticos, anticolinérgicos e em pacientes com diabetes.